

Asthme

L'essentiel

- L'asthme est une maladie non transmissible (MNT) majeure, qui touche aussi bien les enfants que les adultes, et constitue la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants.
 - L'inflammation et le rétrécissement des voies respiratoires fines dans les poumons sont à l'origine des symptômes de l'asthme, qui peuvent prendre la forme d'une toux, d'un sifflement, d'un essoufflement, d'une oppression thoracique ou d'une association de plusieurs de ces symptômes.
 - On estimait que 363 millions de personnes souffraient d'asthme en 2023 (1), et que cette maladie avait entraîné 442 000 décès.
 - Grâce à des médicaments par inhalation, les symptômes de l'asthme peuvent être maîtrisés et les personnes souffrant de cette maladie peuvent mener une vie normale et active.
 - Il est également possible de réduire les symptômes de l'asthme en évitant ce qui le déclenche.
 - La plupart des décès liés à l'asthme surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, où le sous-diagnostic et l'insuffisance des traitements restent problématiques.
 - L'OMS a à cœur d'améliorer le diagnostic, le traitement et le suivi de l'asthme afin de réduire la charge mondiale des MNT et de progresser vers la couverture sanitaire universelle.
-

Vue d'ensemble

L'asthme est une affection pulmonaire chronique qui touche des personnes de tous âges. Elle est causée par l'inflammation et la contracture des muscles autour des voies respiratoires, ce qui rend la respiration plus difficile.

Les symptômes peuvent prendre la forme d'une toux, d'un sifflement, d'un essoufflement et d'une oppression thoracique. Ces symptômes peuvent être légers ou plus graves, et apparaître et disparaître au fil du temps.

L'asthme peut être une maladie grave, toutefois une prise en charge est possible avec un traitement adapté. Les personnes présentant des symptômes de l'asthme doivent consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé.

Impact

L'asthme est souvent sous-diagnostiqué et insuffisamment traité, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Les personnes chez qui l'asthme n'est pas correctement traité peuvent souffrir de troubles du sommeil, de fatigue pendant la journée et de problèmes de

concentration. Les personnes asthmatiques et leur famille peuvent être absentes à l'école ou au travail, ce qui a des conséquences financières sur la famille et l'ensemble de la communauté. En cas de symptômes sévères, les personnes peuvent avoir besoin de soins urgents et être admises à l'hôpital pour y être traitées et surveillées. Dans les cas les plus graves, l'asthme peut entraîner la mort.

Symptômes

Les symptômes de l'asthme peuvent varier d'une personne à l'autre et s'aggravent parfois considérablement. C'est ce que l'on appelle une crise d'asthme. Les symptômes s'aggravent souvent la nuit ou lorsque la personne fait de l'exercice.

Les symptômes courants de l'asthme sont les suivants :

- une toux persistante, surtout la nuit
- une respiration sifflante lors de l'expiration et parfois lors de l'inspiration
- un essoufflement ou des difficultés respiratoires, parfois même au repos
- une oppression thoracique, ce qui rend difficile la respiration profonde.

Certaines personnes développeront des symptômes plus graves en cas de rhume ou de changements météorologiques. D'autres facteurs déclencheurs peuvent inclure la poussière, les fumées, les vapeurs, les pollens de graminées et d'arbres, les poils et les plumes d'animaux, les savons à l'odeur forte ou les parfums.

Les symptômes peuvent également être causés par d'autres affections. Les personnes présentant des symptômes doivent consulter un prestataire de soins de santé.

Causes

De nombreux facteurs différents sont associés à un risque accru d'asthme, mais il est souvent difficile de trouver une cause directe et unique.

- La probabilité de souffrir d'asthme est plus élevée si d'autres membres de la famille sont atteints de cette maladie, notamment des membres de la famille proche comme un parent, un frère ou une sœur.
- L'asthme est plus fréquent chez les personnes présentant d'autres manifestations allergiques telles que l'eczéma et la rhinite (rhume des foins).
- L'urbanisation est associée à une augmentation de la prévalence de l'asthme, probablement en raison de plusieurs facteurs liés au mode de vie.
- Les événements au début de la vie affectent les poumons en développement et peuvent augmenter le risque d'asthme – insuffisance pondérale à la naissance, prématurité, exposition à la fumée du tabac et à d'autres sources de pollution atmosphérique et infections des voies respiratoires d'origine virale, notamment.
- On pense également que l'exposition à différents allergènes et produits irritants de l'environnement augmente le risque d'asthme, notamment l'exposition à la pollution de l'air intérieur et extérieur, aux acariens de

poussière de maison, aux moisissures ainsi que l'exposition à des produits chimiques, à des fumées ou vapeurs, ou à la poussière sur le lieu de travail.

- Les enfants et les adultes en surpoids ou obèses sont plus exposés au risque d'asthme.

Traitement

Il n'est pas possible de guérir l'asthme, mais il existe plusieurs traitements. Le traitement le plus courant consiste à utiliser un inhalateur, qui diffuse le médicament directement dans les poumons.

Grâce à des médicaments par inhalation, l'asthme peut être maîtrisé et les personnes souffrant de cette maladie peuvent mener une vie normale et active.

On distingue trois types d'inhalateurs :

- les bronchodilatateurs (tels que le salbutamol), qui ouvrent les voies aériennes et soulagent les symptômes ;
- les stéroïdes (tels que la béclométhasone), qui réduisent l'inflammation dans les voies respiratoires – ce qui améliore les symptômes de l'asthme et réduit le risque de crises d'asthme graves et de décès ; et
- les inhalateurs combinés, composés à la fois d'un bronchodilatateur et d'un stéroïde.

Les personnes qui souffrent d'asthme ont parfois besoin d'utiliser leur inhalateur tous les jours. Le traitement dépend de la fréquence des symptômes et des différents types d'inhalateurs disponibles.

L'utilisation d'un inhalateur peut être difficile, en particulier pour les enfants ou en situation d'urgence. L'utilisation d'un dispositif d'espacement facilite l'utilisation d'un inhalateur aérosol. Cela aide le médicament à atteindre plus facilement les poumons. Une chambre d'inhalation est un contenant en plastique avec un embout buccal ou un masque facial à une extrémité et un trou pour l'inhalateur à l'autre extrémité. Une chambre d'inhalation fabriquée de manière artisanale avec une bouteille en plastique de 500 ml peut être aussi efficace que les chambres d'inhalation fabriquées commercialement.

L'accès aux inhalateurs est problématique dans de nombreux pays. En 2023, des bronchodilatateurs susceptibles de sauver des vies étaient disponibles dans les établissements publics de soins de santé primaires de moins des deux-tiers des pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et des inhalateurs de stéroïdes étaient disponibles dans moins de la moitié de ces pays.

Il est par ailleurs important de sensibiliser la population afin de mettre un terme aux idées reçues et à la stigmatisation associées à l'asthme dans certains milieux.

Autoprise en charge

Les personnes asthmatiques et leur famille ont besoin d'être informées pour mieux comprendre leur maladie ; notamment leurs options de traitement, les facteurs déclencheurs à éviter et la façon de gérer leurs symptômes à la maison.

Il est important que les personnes souffrant d'asthme sachent comment augmenter leur traitement lorsque leurs symptômes s'aggravent afin d'éviter une crise grave. Les prestataires de soins de santé peuvent fournir un plan d'action contre l'asthme pour aider les personnes souffrant de la maladie à mieux contrôler leur traitement.

Action de l'OMS

L'asthme figure dans le Plan d'action mondial de l'OMS pour la prévention et la lutte contre les MNT et dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

L'OMS prend différentes mesures pour améliorer le diagnostic et le traitement de l'asthme.

L'ensemble d'interventions essentielles de l'OMS pour lutter contre les maladies non transmissibles a été conçu pour aider à améliorer la prise en charge des MNT dans le cadre des soins primaires là où les ressources viennent à manquer. Il comprend des protocoles pour l'évaluation, le diagnostic et la prise en charge des maladies respiratoires chroniques (asthme et bronchopneumopathie chronique obstructive) et des modules contenant des conseils en matière d'hygiène de vie, notamment de sevrage tabagique et d'autoprise en charge.

L'OMS élabore actuellement de nouvelles lignes directrices sur le diagnostic et la prise en charge de l'asthme dans le cadre des soins primaires.

Il est important de réduire l'exposition à la fumée de tabac, à la fois pour la prévention primaire de l'asthme et pour la prise en charge de la maladie. La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac permet de réaliser des progrès dans ce domaine, tout comme certaines initiatives de l'OMS telles que le programme MPOWER et mTobacco Cessation.

La pollution de l'air est un facteur de risque important pour l'asthme, puisqu'elle provoque de nouveaux cas et aggrave les affections existantes. L'OMS a mis au point une formation sur la pollution atmosphérique à l'intention des agentes et agents de santé, qui met en évidence ce lien et offre des conseils pratiques pour réduire et atténuer l'exposition.

L'Alliance mondiale contre les affections respiratoires chroniques contribue aux activités de l'OMS destinées à prévenir et à combattre les maladies respiratoires chroniques. Il s'agit d'une alliance volontaire d'organisations et d'institutions nationales et internationales de nombreux pays attachées à la vision d'un monde où tous les peuples respirent librement.

Références bibliographiques

1. Global Burden of Disease Collaborative Network. [Global Burden of Disease Study 2023 \(GBD 2023\)](#). Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME); 2025.